

## ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКОГО В УСЛОВИЯХ ТОРАКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПООД

Кравчук В.А.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

При патологических образованиях легких малого размера хирургическое лечение способствует верификации диагноза и позволяет выполнить операцию в более ранние сроки. В 10—40% наблюдений точный диагноз удается поставить только после диагностической торакотомии. Использование активной хирургической тактики без применения дополнительных методик сразу при выявлении периферического образования в легком имеет сторонников, так как это улучшает результаты лечения рака легкого, на эффективность которого существенно влияют сроки его диагностирования. В любом случае хирургическое лечение должно применяться, когда с помощью неинвазивных и инвазивных методов диагностики не представляется возможным исключить злокачественную природу образования.

В торакальном отделении ПООД за 3 года проведено 105 операций по поводу периферических образований легких. Средний возраст оперированных больных составил 51,5 года. При этом в возрасте 50-59 лет - 27%, 60-69 лет - 29%, старше 70 лет - 9%. Более 70 % составили мужчины. По локализации образования верхней доли 42%, средней доли 8%, нижней доли 50%.

Установлена онкологическая патология у 56 пациентов. По гистологической структуре у 33 пациентов плоскоклеточный рак легкого, у 8 аденокарцинома легкого, у 6 железисто-плоскоклеточный, у 5 бронхоальвеолярная карцинома, мелко-клеточный рак у 3, а в 1 случае злокачественный карциноид.

У 49 пациентов установлена неонкологическая патология, у 21 больного туберкулез различных форм (очаг Гона, тубер-

кулома, кавернозный и др.), в 7 случаях доброкачественные опухоли (хондрома, гамартохондрома и др.), у 7 больных эхинококк, киста легкого у 5, хроническая пневмония с карнификацией у 4, одиночный мешотчатый бронхоэктаз у 3, в 2 случаях небольшой хронический абсцесс.

По данным ряда авторов, даже в случае малого (до 1,5 см) рака легкого метастазы в лимфоузлах обнаруживаются в 15 – 20% случаев, в то время как при размере опухоли до 1 см таковых нет, в настоящее время не существует методик, позволяющих уверенно исключить рак легкого в случае обнаружения периферического образования легкого, не прибегая к операции, радикальные резекции при более высокой послеоперационной летальности и значительном снижении качества жизни не дают преимуществ в плане 5-летней выживаемости по сравнению с менее инвазивными вмешательствами.

По характеру выполненных манипуляций операции распределены следующим образом: пульмонэктомия 1, комбинированные резекции 2, билобэктомии 3, лобэктомии с лимфодиссекцией 12, сегментэктомия с лимфодиссекцией, типичная лобэктомия у 44, полисегментарная резекция 7, а презиционная резекция выполнена у 4 больных.

Таким образом, по данным ПООД при патологических образованиях легких преобладает онкопатология, которая составляет 53%, на втором месте туберкулез 20 %, остальная патология менее значима. Только хирургическое лечение позволило достоверно установить диагноз. В 90% случаев произведена радикальная резекция с точки зрения онколога.

## ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРО-КТ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА ГОРОДА АЛМАТЫ

Курсанова Н.Р.

Городской Онкологический диспансер, г.Алматы, Казахстан

Актуальность. В структуре заболеваемости и смертности рак желудка занимает одно из ведущих мест. Лечение больных, прогноз результатов лечения зависят от точности и полноты диагностической информации о распространенности опухолевого процесса. Для адекватной диагностики необходимы детальные данные о местной, регионарной распространенности опухоли и наличия отдаленных метастазов. Требуется полная информация об особых проявлениях опухоли: определение локальной распространенности процесса, глубины поражения стенки желудка, выявления опухоли инвазии в клетчаточные пространства, наличие метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, стадирование опухоли. На основании точных сведений о степени распространения опухоли, полученных до начала лечения, основывается тактика дальнейшего комплексного и комбинированного лечения.

Цель исследования. Предоперационная оценка степени распространенности рака желудка.

Материалы и методы. С целью изучения возможностей гидро-КТ в оценке распространенности опухолевого процесса, обследовано 46 пациентов с раком желудка. Гидро-КТ основана на оптимальном растяжении желудка негативным контрастным средством: водой в сочетании с внутривенным контрастированием. Исследование проводится натощак, пациент не должен принимать пищу в течении 12 ч. Для стандартного исследования пациенты принимали 1000-1500 мл воды за 30 мин до исследования, непосредственно перед сканированием 500 мл для оптимального растяжения желудка.

Сканирование охватывало области от диафрагмы до седалищных бугров с целью определения распространенности опухолевого процесса и выявления висцеральных метастазов. Использовался протокол сканирования, также обеспечивающий оптимальную оценку печени. Проводилось нативное исследование и сканирование в портальную фазу. В портальной фазе происходит контрастное усиление утолщенной стенки желудка и пораженных лимфоузлов. В 44 случаях из 46 выявлено накопление контрастного средства опухолью. Определялась локализация, протяженность процесса, глубина поражения стенки желудка, опухолевая инвазия в клетчаточные пространства, диагностика метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, стадирование опухоли. Лимфатические узлы более 5 мм округлой формы с контрастным усилением расценивались в большинстве случаев как метастатические.

Особо важное значение имеет гидро-КТ желудка для диагностики и степени распространения скirroзного рака, преимущественном подслизистом распространении опухоли, отсутствием верификации диагноза после гастроскопии. Также для хирургов предоставляются дополнительные сведения о местном распространении опухоли, вовлечения в процесс сосудов, что является очень важным в оценке резектабельности опухоли. После проведения оперативного вмешательства изучался протокол операции, операционный материал и патоморфологическое заключение. На основании сопоставления данных КТ и патоморфологического заключения оценивались возможности метода. У двух пациентов из 46 не удалось

обнаружить опухоль при т.н. «малом раке». Остаются трудности при выявлении микроскопической инвазии в клетчатку, серозную оболочку, идентификация мелких перитонеальных метастазов.

Выводы. Гидро-КТ желудка по полноте получаемой информации для предоперационной оценки имеет значительные преимущества перед обычной компьютерной томографией. Контрастное усиление утолщенной стенки желудка и пораженных лимфоузлов является надежным методом диагностики. Точность в определении локализации опухоли, протяженности процесса, глубины поражения стенки желудка, опухолевой

инвазии в клетчаточные пространства, диагностики метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, оценке степени местного распространения, особенностей роста опухоли и ее осложнений позволяет рекомендовать гидро-КТ желудка для предоперационной оценки степени распространенности рака желудка, оценке резектабельности опухоли. Особенно важным методом диагностики гидро-КТ желудка является при скirrрозном раке, при отсутствии морфологической верификации. Однако диагностика ранних форм рака при гидро-КТ затруднительна.

## ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СУТЕНТ В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ ГОРОДСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПЕНСERA Г. АЛМАТЫ

*Люмозова Г.Г., Турешева А.О.*

*Городской онкологический диспансер г. Алматы, Республика Казахстан*

Таргетные противоопухолевые препараты, направленные на ингибирование ангиогенеза, считаются одним из основных прорывов в медицине за последние десятилетия.

Новые таргетные препараты предлагают широкие возможности для паллиативного лечения больных с распространенным раком почки, однако в настоящее время не существует единого стандарта лечения таргетными препаратами, а осуществляется индивидуализированный алгоритм выбора схемы лечения.

Сунитиниб (Сутент) представляет собой ингибитор тирозинкиназы, который направлен против нескольких рецепторов VEGF и PDGF.

За период с марта по июль 2011г. нами было пролечено 5 пациентов с раком почки с использованием таргетного препарата Сутент. У 4 пациентов до начала терапии Сутентом отмечалось прогрессирование основного процесса с возникновением отдаленного метастазирования, 1 пациент изначально имел запущенную IV стадию заболевания с метастазами в правый надпочечник, поджелудочную железу. Всем пациентам на 1 этапе проведено хирургическое лечение в объеме нефрэктомии.

3 пациентов из 5 ранее получали специальное лечение по поводу основного заболевания (иммунотерапия, таргетная терапия авастинном либо нексаваром), 2 пациентов химио-иммуно-таргетную терапию не получали.

Из 5 пациентов 3 получили 3 курса, 2 пациента 2 курса таргетной терапии Сутентом, в рекомендованном режиме использования препарата: по 50 мг в день перорально в течение 28 дней, с перерывом между курсами в 2 недели. Переносимость терапии у всех пациентов была удовлетворительная, еженедельно проводился контроль лабораторных показателей (общий анализ крови, биохимический анализ крови с оценкой печеночных проб, азотистых шлаков; общий анализ мочи и коагулограмма по показаниям), электрокардиография между курсами таргетной терапии.

Субъективный положительный ответ на терапию Сутентом отмечается у всех 5 пациентов в виде уменьшения основных симптомов заболевания (кашля, одышки, болевого синдрома). У 3 пациентов до начала терапии Сутентом статус по шкале Карновского составлял 70%, у 2 пациентов – 80%, после лечения статус по шкале Карновского соответственно составил 80% у 3 пациентов, 90 % у 2 пациентов.

На настоящий момент по данным контрольного инструментального обследования, включающего компьютерную томографию органов грудной клетки, брюшной полости нами отмечены следующие результаты: частичная регрессия процесса достигнута у 2 пациентов, стабилизация процесса с положительной динамикой достигнута у 3 пациентов.

Из отмеченных нами побочных действий наблюдалась постлекарственная токсичность 1-2 степени в виде явлений диспепсии (тошнота и снижение аппетита) у 4 пациентов, мукозит слизистой полости носа у 1 пациента, дерматологические реакции (эритематозная сыпь, сухость кожи, эритема) у всех пациентов, явлений астении у 3 пациентов. Указанные побочные действия не требовали снижения дозы Сутента, купирующего лечения, купировались самостоятельно. Клинически значимых изменений со стороны лабораторных показателей, электрокардиографии у всех 5 пациентов не наблюдалось. Таким образом, лимитирующая токсичность после терапии Сутентом нами не отмечалась.

Таким образом, новая эра в лечении метастатического либо распространенного рака почки с использованием таргетных препаратов, в частности препарата Сутент поможет большинству больных увеличить продолжительность и качество жизни и иметь контроль над опухолевым процессом. Накопление большего числа пациентов, анализ полученных результатов лечения, а также последовательность в назначении препаратов позволят в дальнейшем оптимизировать лечение метастатического рака почки.

## ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОВИРУСНОГО ЛЕЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

*Акимжанова С.М.*

*Городской онкологический диспансер, г.Алматы*

В Казахстане раком шейки матки (РШМ) ежегодно болеет более 1000 женщин.

Широкое внедрение скрининговых программ в нашей Республике позволило повысить уровень своевременной диагностики фоновых, предраковых состояний шейки матки, начальных форм РШМ, а также адекватного их лечения. На первое место из известных этиологических факторов выходит папилломавирусное (ВПЧ) поражение шейки матки, являю-

щееся предшественником цервикальных интраэпителиальных неоплазий (дисплазий) и затем рака шейки матки. Существует несколько вариантов комплексной противовирусной терапии при лечении предрака и рака шейки матки.

В нашей клинике уже около 10 лет проводятся практические исследования, направленные на улучшение результатов комплексной терапии предрака и преинвазивного РШМ, с применением деструктивных методов лечения совместно с

противовирусными и иммуномодулирующими препаратами. В качестве основного деструктивного метода лечения при дисплазии II-III степени и преинвазивного РШМ у молодых женщин мы используем электрохирургическую конизацию шейки матки. Обязательным считается в предоперационном и послеоперационном периодах проведение курса противовоспалительного, противовирусного местного и системного лечения.

Целью нашего исследования являлось повышение эффективности комплексного лечения больных с предраковыми и преинвазивными формами рака шейки матки путем применения этиопатогенетической противовирусной терапии. Одним из препаратов выбора с местным иммуномодулирующим и противовирусным действием является «Эпиген интим» спрей. Активным действующим веществом данного препарата служит глицирризиновая кислота на основе растительной субстанции. «Эпиген интим» спрей обладает комплексным иммуномодулирующим, противовирусным, противовоспалительным воздействием, удобен для пациентов при самостоятельном применении.

В исследование были включены 250 женщин фертильного возраста с различной степенью дисплазии и преинвазивного рака шейки матки. Средний возраст пациенток составил  $36,8 \pm 5,5$  лет. При диагностике был использован общепри-

нятый алгоритм, включающий расширенную кольпоскопию, цитологическое, патоморфологическое исследования и титрование ВПЧ методом полимеразной цепной реакции. Препарат «Эпиген интим» спрей назначался вагинально по 3-4 раза в день в течение 15 дней в предоперационной подготовке и после деструкции шейки матки 15-20 дней. При оценке эффективности лечения в предоперационном периоде в 98% случаев отмечалось уменьшение патологических выделений из половых путей. После электроконизации шейки матки наблюдалось раннее и равномерное отторжение струпа. При контрольной кольпоскопии была отмечена активная краевая эпителизация деструктивной поверхности, сокращение сроков репарации и полной эпителизации. Контрольное цитологическое исследование в течение двух лет в 98% случаев не выявило рецидива заболевания.

Выводы: 1. Местное применение препарата «Эпиген интим» спрей активизировало противовоспалительное лечение в предоперационном периоде. 2. Противовирусный и противовоспалительный эффект «Эпигена» в комплексной терапии ускорил процессы репарации и эпителизации шейки матки после деструкции. 3. При дальнейшем применении с профилактической и лечебной целью препарат блокирует размножение вирусов и развитие рецидива заболевания.

## ОПЫТ РАБОТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПИЩЕВОДА

Мусулманбеков К.Ж., Шауенов Е. С.

Карагандинский государственный медицинский университет,  
КГКП «Областной онкологический диспансер» г. Караганда

Рак пищевода является краевой патологией для Казахстана, среди злокачественных опухолей занимает пятое место с заболеваемостью 8,1 и смертностью 6,9 на 100000 населения (2009).

Данная патология представляет одну из сложных проблем клинической онкологии в вопросе лечения. Особенно сложным представляется лечение среднелюбогического отдела пищевода. Несмотря на более 100 летний период разработки хирургическое лечение данной локализации применяется только в специализированных клинических центрах. Резекция среднелюбогического отдела пищевода чревата высокими послеоперационными осложнениями и летальностью.

Только в конце XX – века, за счет внедрения функционально надежных анастомозов и повышения техники выполнения операции, снижен риск так называемых «хирургических» осложнений и послеоперационной летальности.

К одному из центров разработки методов хирургического лечения, относится клиника онкологии Карагандинского государственного медицинского университета.

За период с 1970 по 2010 г.г. на базе КГКП «областной онкологический диспансер» выполнено 346 радикальных операции на пищеводе, из них 174 резекции среднелюбогического отдела пищевода.

Возрастной состав больных, подвергнутых резекции среднелюбогического отдела пищевода следующий: 30 – 39 лет – 4 (2,3 %), 40 – 49 лет – 32 (18,4 %), 50 – 59 лет – 62 (35,6 %), 60 – 69

Таблица 2. Характер и объем выполненных операции

| № п/п | Объем и характер операции                                                           | Количество больных | Осложнения  | Летальность |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1     | Резекция среднелюбогического отдела пищевода по типу Люиса                          | 107                | 28 (26,2 %) | 13 (12,1 %) |
| 2     | Резекция среднелюбогического отдела пищевода левосторонним чресплевральным доступом | 60                 | 14 (23,3 %) | 7 (11,7 %)  |
| 3     | Экстирпация пищевода с формированием пищеводно-желудочного анастомоза на шее.       | 7                  | 2           | -           |
| Итого |                                                                                     | 174                | 42 (24,1 %) | 20 (11,5 %) |

лет – 68 (39,1 %), 70 лет и старше – 8 (4,6 %), самому старшему 77 лет. Мужчин – 112 (64,4 %), женщин – 62 (35,6 %).

Объем и характер выполненных операции приведены в таблице № 2.

Среди послеоперационных осложнений ведущее место заняла недостаточность пищеводно – желудочного анастомоза, в 10 случаях приведшее к летальному исходу. На втором месте сердечно – сосудистая недостаточность (5), в трех случаях являвшийся причиной летального исхода. В 3 случаях встречали некроз трансплантата с летальным исходом в 2х случаях.

За последние 8 лет резко уменьшилось количество послеоперационных осложнений и летальность, так на 85 операции летальность составила 3,5 % (3 больных). В этой группе больных мы не встречали ни одного случая недостаточности швов анастомоза.

Комбинированная резекция произведена 24 больным, что составила 13,8 %. Летального исхода среди больных подвергнутых комбинированной резекции пищевода не было.

## ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Структура онкологической службы в Павлодарской области выглядит следующим образом. Первичным подразделением онкологической сети является онкологический кабинет в центральной районной больнице. На онкологический кабинет

возлагаются следующие важные задачи: организация учета и регистрация онкологических больных, т.е. ведение онкологической документации в районе обслуживания поликлиники; диспансерное наблюдение за онкологическими больными,

состоящими на учете и диспансеризация больных с предраковыми заболеваниями. Большинство больных предраковыми заболеваниями должны выявляться, учитываться и лечиться у врачей-специалистов общей сети. Все факультативные предраки кожи находятся в ведении дерматолога, хронические анацидные гастриты, хронические пневмонии - терапевта, определенный круг больных - гинеколога, окулиста, отоларинголога. У врача онкологического кабинета должны быть на диспансерном наблюдении все больные со злокачественными новообразованиями, доброкачественными новообразованиями молочных желез (фиброаденома, фиброаденоматоз), ворсинчатыми полипами желудочно-кишечного тракта.

Всех взятых под диспансерное наблюдение больных распределяют на клинические группы: группа Ia - больные с заболеванием, подозрительным на злокачественное новообразование; группа Ib - больные с предопухолевыми заболеваниями; группа II - больные злокачественными новообразованиями, подлежащие специальному (радикальному) лечению; группа IIa - больные злокачественными новообразованиями, подлежащие радикальному лечению; группа III - практически здоровые лица (после проведенного радикального лечения злокачественной опухоли); группа IV - больные с распространенными формами злокачественных новообразований, подлежащие паллиативному или симптоматическому лечению.

Пациентов группы Ia по мере установления окончательного диагноза снимают с учета или переводят в другие группы. Углубленное обследование больных Ia клинической группы

должно быть организовано не позднее чем через 10 дней с момента взятия на диспансерный учет.

Павлодарский областной онкологический диспансер является единственным лечебно-профилактическим учреждением, обеспечивающим население квалифицированной и специализированной стационарной и поликлинической онкологической помощью, осуществляет организационно-методическое руководство лечебно-профилактическими учреждениями по вопросам онкологии, обеспечивает специализацию и повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала в области диагностики и лечению больных злокачественными новообразованиями. В структуре онкологического диспансера развернуты следующие функциональные подразделения: стационар, поликлиника, лаборатории (клиническая, цитологическая, патоморфологическая), рентгенологическое отделение, организационно-методический кабинет. Стационарную помощь населению Павлодарской области оказывают торакальное отделение на 40 коек, отделение общей онкологии на 50 коек, радиологическое отделение на 50 коек, отделение химиотерапии на 30 коек. Дневной стационар при диспансерном отделении и стационар дневного пребывания при радиологическом отделении позволяют проводить стационарозамещающую помощь онкологическим больным.

Научно-методическую, организационно-методическую и лечебно-профилактическую работу проводит Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

## ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬНЫХ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Садвакасова Г.С., Каракушикова А.С., Шортанбаев А.А.*

*Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, кафедра иммунологии и аллергологии, г.Алматы*

Актуальность. Рак молочной железы является одним из самых распространенных заболеваний у женщин. Одним из основных условий возникновения злокачественных новообразований в организме является нарушение функции иммунной системы.

Цель исследования. Изучить особенности иммунологических показателей у больных с доброкачественными новообразованиями молочной железы.

Материал и методы исследования. Проведен анализ Т-клеточного звена системы иммунитета у 23 больных доброкачественными новообразованиями молочной железы (ДНМЖ). Исследовались женщины от 35 до 65 лет. Контрольную группу составили 17 практически здоровых женщин аналогичного возраста без патологических изменений в молочной железе.

Типирование лимфоцитов проводилось в реакции непрямой иммунофлюоресценции при визуальном контроле результатов с использованием моноклональных антител CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD95+, CD25+, CD11b+ производства ЗАО «Вектор-Бест» г.Новосибирск.

Результаты и их обсуждение. При исследовании показателей клеточного иммунитета было установлено, что показатели

как относительного, так и абсолютного количества CD3+, CD4+, CD8+, CD16+ и CD95+- лимфоцитов в периферической крови у больных ДНМЖ достоверно не различались с контрольной группой. Однако в исследуемой группе наблюдалось статистически значимое увеличение относительного (в 2,5 раза) и абсолютного (в 3,2 раза) количества CD11b+-лимфоцитов по сравнению с группой контроля. В оценке иммунного статуса онкологических больных особое внимание уделяется активационным антигенам, таким как CD25+. У больных ДНМЖ было выявлено повышение, как и относительного (в 2,2 раза), так и абсолютного количества (в 2,9 раза) CD25+- лимфоцитов по отношению к их уровню в контрольной выборке. Соотношение CD25/CD95 достоверно повысился в 3,3 раза по отношению к контролю за счет повышения CD25+-лимфоцитов.

Выводы. Таким образом, на стадии предопухолевых изменений в ткани молочной железы отмечаются изменения субпопуляционного состава иммунокомпетентных клеток, а именно активация CD11b+- и CD25+ -лимфоцитов, что позволяет определить течение заболевания и определить риск развития злокачественного новообразования.

## ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАРНОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ РАКА ГОРТАНОГЛОТКИ

*Тулебаев Р.К., Исмагулова Э.К., Шагатаева Б.А.*

*Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова*

Для нижнего отдела глотки закономерно более частое и раннее метастазирование в регионарные лимфатические узлы шеи по сравнению с гортанью (от 50 до 89%).

Цель исследования: анализ особенностей метастазирования и лечения злокачественных опухолей гортаноглотки.

Материал и методы исследования: Из 52 больных с поражением проксимального (перепончатого) отдела гортаноглотки у 32 (60,4+7,1%) имел место инфильтрат без изъязвления, у 15 (22,9+6,1%) – инфильтрат с изъязвлением, а у 12 (16,7+5,4%) – экзофитная форма роста. Причем при инфильтративной и

инфильтративно-язвенной формах метастазы в шейные лимфатические узлы отмечены более чем в 2 раза чаще (89,6%), чем при экзофитной форме роста (38,4 %), у 48% больных метастазы были множественными, у 21,2% - двухсторонними. Морфологически в 90,2% выявлен плоскоклеточный рак, в 9,8% - прочие.

Результаты исследования: У пациентов с первичной опухолью, соответствующей Т3-Т4 без регионарных метастазов трехлетняя выживаемость составила 48,1%, пятилетняя – 42,3% (21 и 17 из 46 человек соответственно). Наличие же регионарных метастазов, соответствующих N1 и N2 с аналогичной распространенностью первичной опухоли снижало отдаленные результаты в среднем в 1,3 раза: трехлетняя выживаемость составила 36,5% (8 человек) и пятилетняя – 31,6% ( 7 человек из 38).

Наилучшие результаты лучевой терапии получены у пациентов со степенью распространения первичной опухоли Т2 при отсутствии регионарных метастазов. При наличии регионарного метастазирования более трех лет не прожил ни один пациент. Следует отметить, что в ближайшие сроки окончания лучевого лечения у 12 пациентов из 27 с метастазами, соответствующими N2 имела полная или частичная регрессия метастатической опухоли, однако по окончании курса лучевой терапии в сроки 4-18 месяцев возникал рецидив. При проведении комбинированного лечения отмечалось повышение трех- и пятилетней выживаемости у больных с распространенными первичными опухолями. У пациентов с первичной

опухолью соответствующей Т3 (43 человека) трехлетняя выживаемость составила 66,28% (живы 29) пятилетняя -56,98% (25 человек). Тогда как у пациентов со стадией Т3 N0M0 при хирургическом лечении трехлетняя выживаемость составила 50% (из 22 человек живы 11), пятилетняя -45,45% (живы 10 из 22 человек).

При анализе непосредственных результатов комплексного лечения больных раком гортаноглотки полной ремиссии не наблюдалось ни у одного пациента, частичная имела у 11 (31,43%), стабилизация и прогрессирование наблюдалось в равных количествах – по 12 больных (34,29%).

Выводы: 1. Наличие у больного раком гортаноглотки клинически определяемых метастазов в регионарные лимфатические узлы является показанием для шейной лимфодиссекции или операции Крайля;

2. при клинически не определяемых метастазах (N0) возможно лишь облучение зоны путей лимфооттока, но пациент должен находиться под строгим динамическим наблюдением, и в случае появления метастазов подвергнут хирургическому вмешательству;

3. при распространенных злокачественных опухолях гортаноглотки комбинированный метод лечения более эффективен, чем чисто хирургический и лучевой. Однако, учитывая высокий процент осложнений после предоперационного облучения (62,5% против 32,3% при послеоперационном облучении), лечение следует начинать с хирургической операции.

## ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ САРКОМой МАТКИ

*Имендинова Д. У., Шакирова А. Ф., Дзюбина Т. С.*

*КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан*

Задачи исследования: анализ результатов лечения больных саркомой матки (СМ).

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 213 больных с диагнозом саркома матки, находившихся на лечении в отделении онкогинекологии КГКП «ООД» за период с 1990 по 2008 гг. Средний возраст пациенток составил – 47,8 года.

Среди гистотипов сарком матки лейомиосаркома наблюдалась у (47,4+4,9)% (101 пациентка) и эндометриальная саркома – у (36,2+5,5)% (77 больных), тогда как карциносаркома и смешанная мезодермальная опухоль относятся к редко встречающимся опухолям и составили соответственно: (10,8+6,5)% (23) и (5,6+5,6)% (12 больных).

Среди больных СМ преобладали пациентки с I стадией заболевания (62,0+4,3%), преимущественно с лейомиосаркомой (58,3+5,6%) и эндометриальной стромальной саркомой (28,8+7,3%). Больные по стадиям СМ распределились следующим образом: I стадия была выявлена у (62+4,35)% (132 человека) больных, II – (18,8+6,2)% (40 человек), III и IV стадии: (9,8+6,6)% и (9,4+6,7)% (20 больных).

Среди больных лейомиосаркомой преобладали пациентки с I стадией – 77 больных (58,3+5,6%), над III–IV стадиями – 17 больных (16,8+3,7%). При наличии эндометриальной стромальной саркомы, напротив, преимущественно пациентки имели III–IV стадии – 7 больных (33,3+5,6%) и 9 пациенток (45+11,4%) соответственно, тогда как I-II была лишь у 38 человек (28,8+7,3%) и у 23 больных (57,5+10,5%). При редко встречающихся опухолях – карциносаркоме и смешанной мезодермальной опухоли III-IV стадий выявлена у 5 больных (21,7+8,8%) и 3 больных (25,0+3,7%), соответственно.

Результаты. Больные СМ были разделены на три группы. 1 группа – 62 больных (29,1+5,7%) – получили только хирургическое лечение в объеме экстирпации матки с придатками. 2 группа – 71 больной (33,3+5,6%) – комбинированное лечение (операция + послеоперационная лучевая терапия (ПЛТ) или

адьювантная полихимиотерапия (ПХТ)). 3 группа – 80 больных (37,6+5,4%) – комплексное лечение (операция + ПЛТ + ПХТ).

Общая 3-я и 5-я выживаемость независимо от гистотипа опухоли и ее стадии составила, соответственно – (46,0+8,3)% и (40,8+7,2)%. Общая 5-летняя выживаемость при лейомиосаркоме достоверно выше, чем при эндометриальной стромальной саркоме (49,5+5,0% и 31,2+5,2%) ( $p<0,05$ ). Достоверной разницы между 5-ей выживаемостью больных лейомиосаркомой с пациентками со смешанной мезодермальной саркомой (33,3+13,6%) и карциносаркомой (39,1+10,2%) не выявлено. Лейомиосаркома является наиболее благоприятной формой, при которой отмечены самые высокие показатели выживаемости больных. Общая 5-летняя выживаемость при I стадии независимо от гистотипа опухоли равна (55,3+3,6)%, при II стадии – (30,0+6,8)%, а при III - всего лишь (9,5+2,1)%. При IV стадии саркомы ни одна больная не пережила 5-й срок.

Трех- и 5-е результаты лечения больных СМ в группах больных, получавших хирургическое и комбинированное лечение, оказались практически идентичными. На 5-ю выживаемость больных СМ существенное значение имеет вид лечения. Показатели выживаемости оказались выше ( $p<0,05$ ) у больных, которым проводилась адьювантная химиотерапия – (59,6+6,8)%, тогда как после адьювантной лучевой терапии она составила (31,6+10,7)%. Поэтому в качестве адьювантного лечения более эффективным можно считать химиотерапию.

Пятилетняя выживаемость среди больных без метастазов составила (50,3+3,8)%, при их наличии – (27,3+12,8)%.

Выводы: Общая 3-я и 5-я выживаемость больных саркомой матки составила, соответственно – (46,0+8,3)% и (40,8+7,2)%. Высокие показатели выживаемости при комбинированном и комплексном лечении обусловлены применением адьювантной ПХТ.